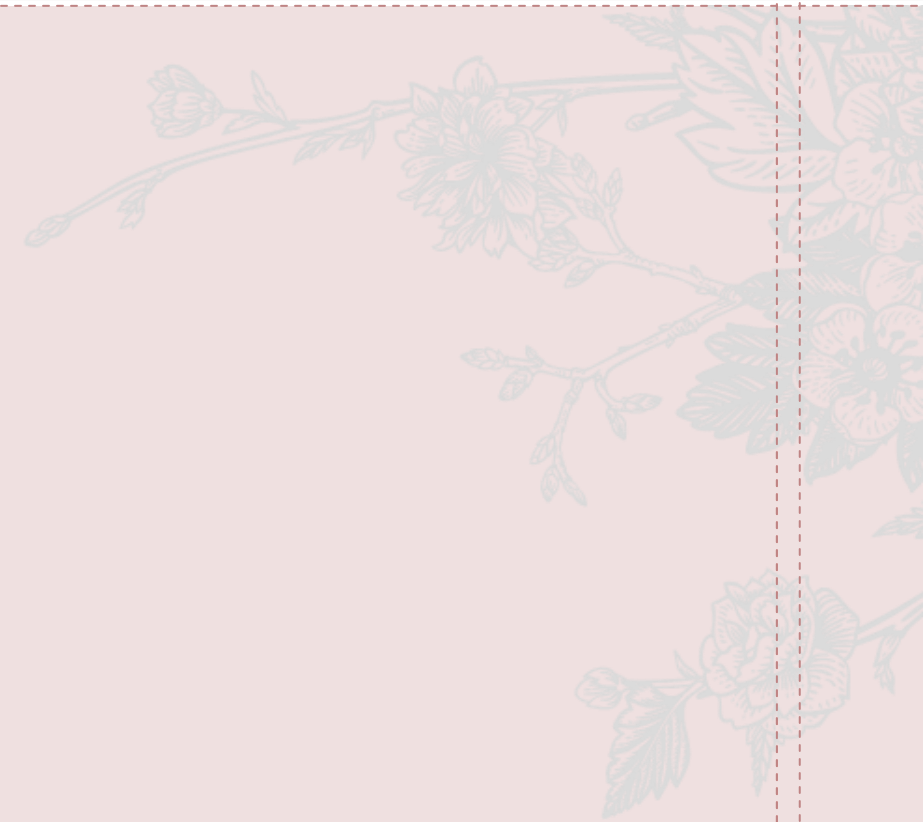
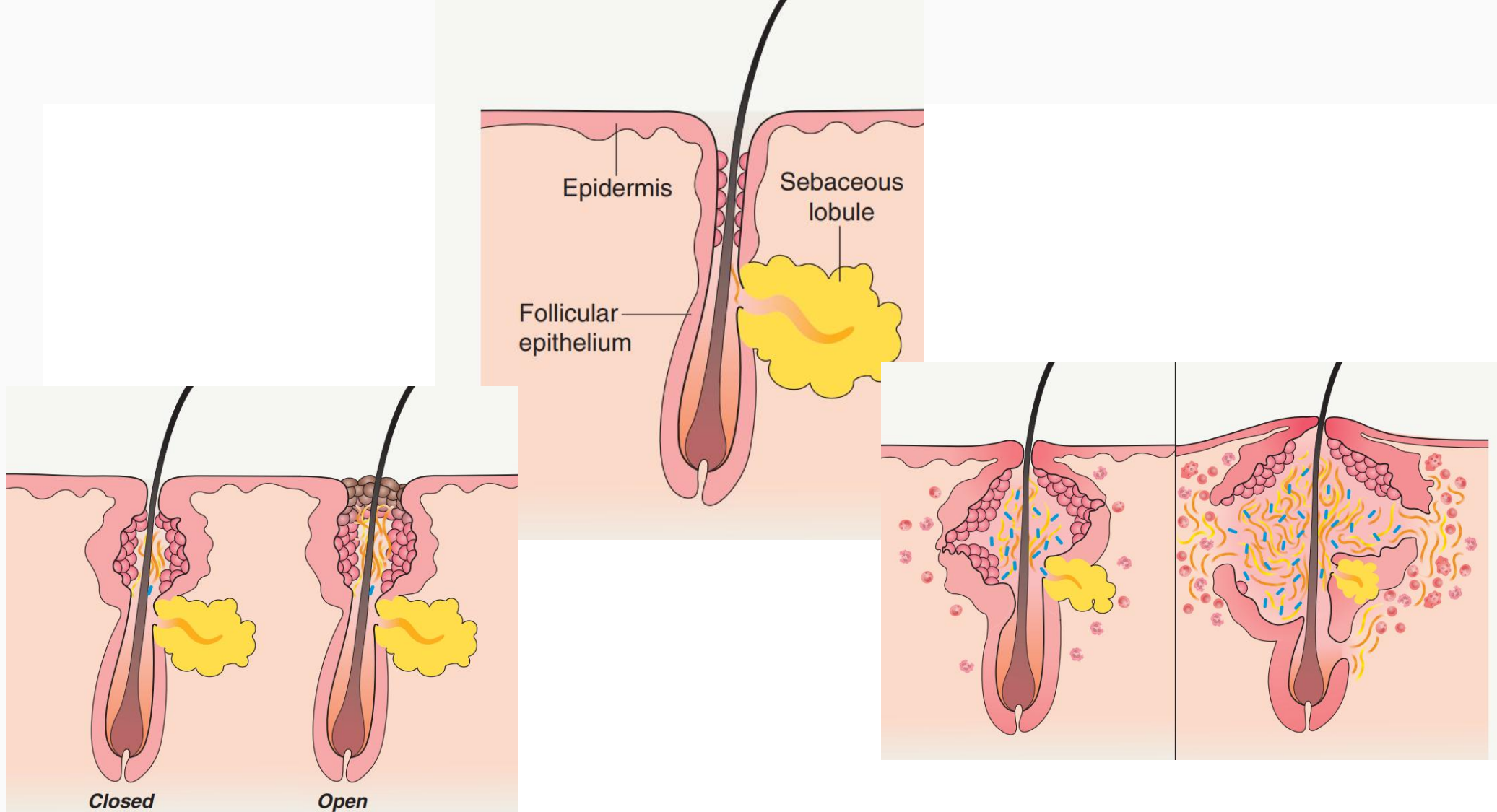


Acneea





1. Hiperkeratoză la nivelul ductului folicular
2. Producție de sebum în exces
3. *Propionibacterium acnes* (+ factori inflamatori)

Acneea este una din cele mai frecvente afecțiuni cutanate, prezenta la adolescenti si tineri

1. Hiperkeratoză la nivelul ductului folicular
2. Producție de sebum în exces
3. *Propionibacterium acnes* (+ factori inflamatori)

Acneea- aspecte clinice

Leziuni de retenție

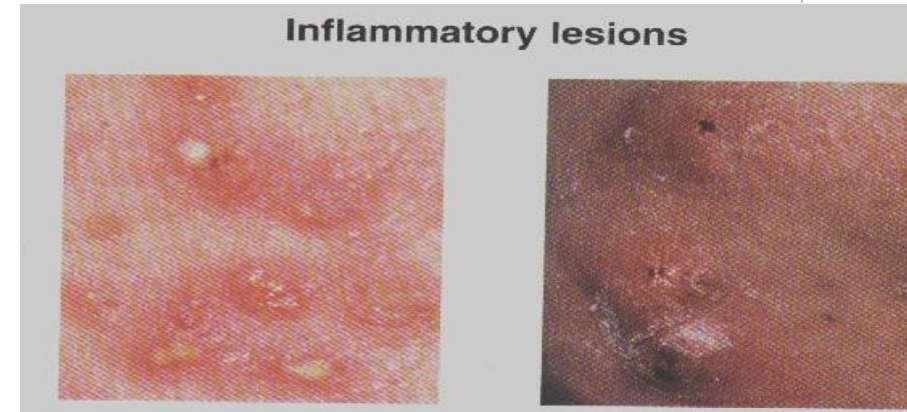
- ♦ **Comedoane închise = microchiste**
- ♦ Papule mici 2-3 mm, culoarea pielii sau albe
- ♦ Acumulare de sebum în canalul folicular dilatat prin obstrucția orificiului
- ♦ Se pot inflama
- ♦
- ♦ **Comedoane deschise = puncte negre**
- ♦ Leziuni de 1-3 mm - acumulare de sebum oxidat
- ♦ Se pot elimina sau inflama



Acneea- aspecte clinice

Leziuni inflamatorii superficiale

- ♦ **Papule**
 - ♦ Leziuni < 5 mm
 - ♦ Eritematoase, consistență fermă, pot fi ușor dureroase
 - ♦ De obicei – după o leziune retențională
 - ♦ Evoluție – rezorbție sau pustule
- ♦ **Pustule**
 - ♦ Conținut purulent galben - acumulare de polimorfonucleare



Acneea- aspecte clinice



Tratament

Terapie topica

- ♦ Retinoizi
- ♦ Peroxid benzoil (exp Kurac, Medigram)
- ♦ Acid azelaic (exp Skinoren, Teen Derm AZ)
- ♦ Antibiotice topice

Terapie sistematica

- ♦ Tratament sistemic (antibiotice sistemice, retinoizi, anticonceptionale)

Proceduri

- ♦ Proceduri: microdermabraziune, peeling chimic, evacuaire comedoane, incizii, etc

Rozacee



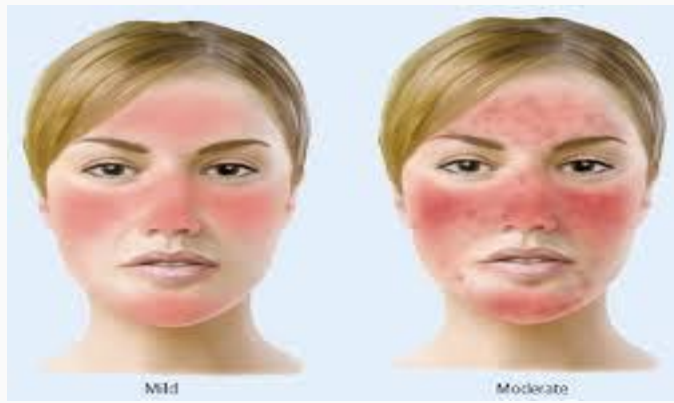
Rozacee

- ♦ Afecțiune cutanată cronică – fototip deschis, F>B, vârstă adultă
- ♦ Evoluție progresivă de la eritem și teleangiectazii la papule și pustule.
- ♦ Patogeneză - predispoziția genetică (reactivitate vasculară crescută), asocierea cu afecțiuni digestive (asocierea cu infecția cu *Helicobacter pylori*), parazitul *Demodex folliculorum*.
- ♦ Factori trigger – temperaturi extreme, expunere la soare/vânt, băuturi fierbinți, alimente condimentate, alcool, exerciții fizice, iritanți topici

Tablou clinic

- ♦ Localizare - față, mai ales în zona centro-facială: obraji, nas, frunte, bărbie.
- ♦ Stadiul I – cuperoză – eritem (tranzitor → persitent) și teleangiectazii
- ♦ Stadiul II - faza papulo-pustuloasă - papule, pustule mici, sterile, uneori scuame fine; nu există comedoane.
- ♦ Stadiul III - Faza fimatoasă - hiperplazie și fibroză a glandelor sebacee de la nivelul feței (nas - rinofimă).





Tratament

Terapie topica

- ♦ Acid azelaic (exp Skinoren, Teen Derm AZ)
- ♦ Antibiotice topice

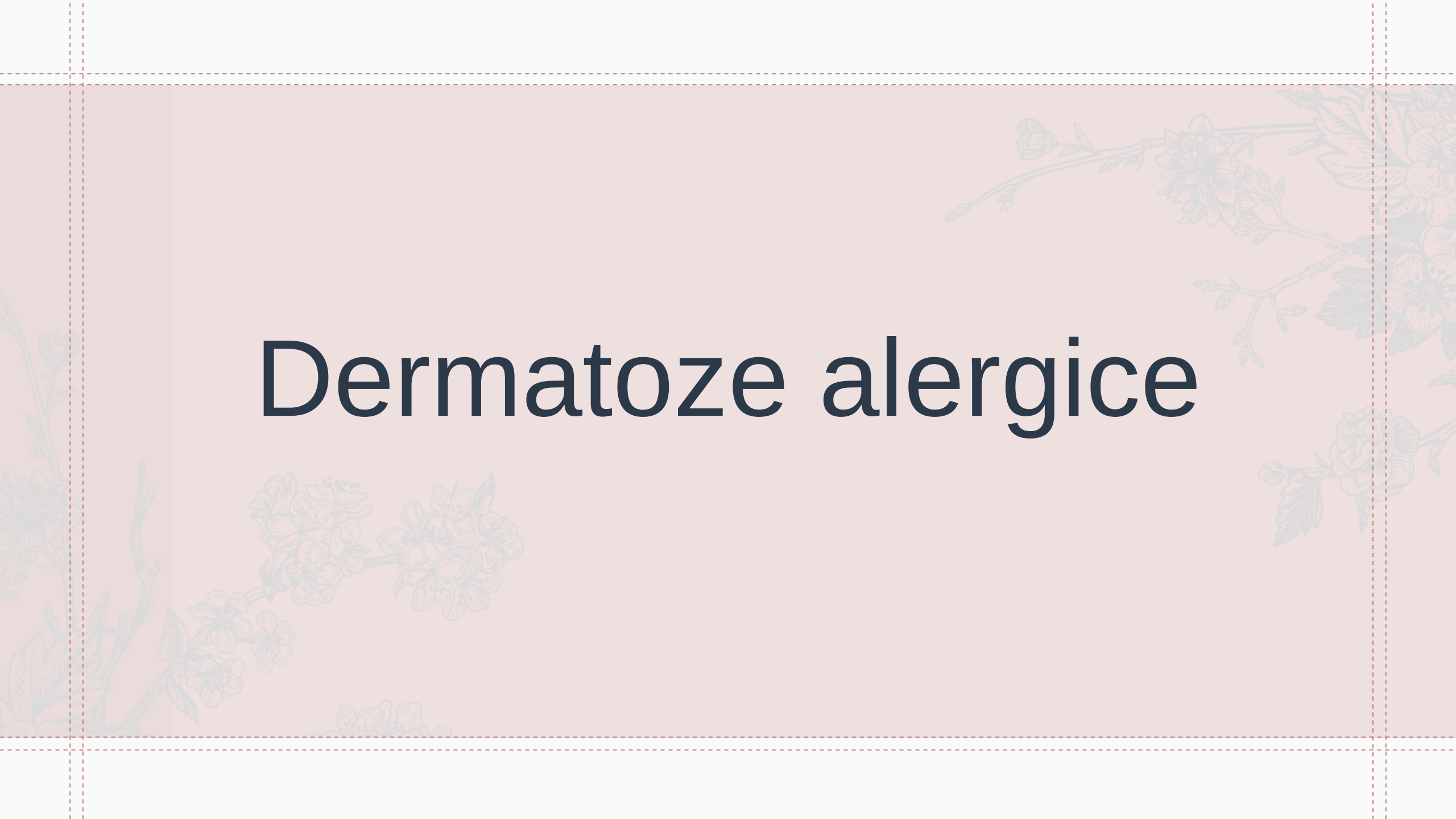
Terapie sistematica

- ♦ Tratament sistemic (antibiotice sistemice)

Proceduri

- ♦ Tratament laser – IPL, Nd-Yag, CO2-ablativ

Dermatoze alergice

The image features a light pink rectangular area in the center, which serves as a background for the text. This area is framed by a thin, dashed brown border. The background of the entire image is white, decorated with faint, stylized green line drawings of flowering branches and leaves. The text 'Dermatoze alergice' is written in a large, dark blue, sans-serif font, centered within the pink rectangle.

Dermatoze alergice

Dermatite:

Dermatita de contact

Dermatita atopica

Dermatita seboreica

Urticarii

Vasculite

Reactii postmedicamentoase



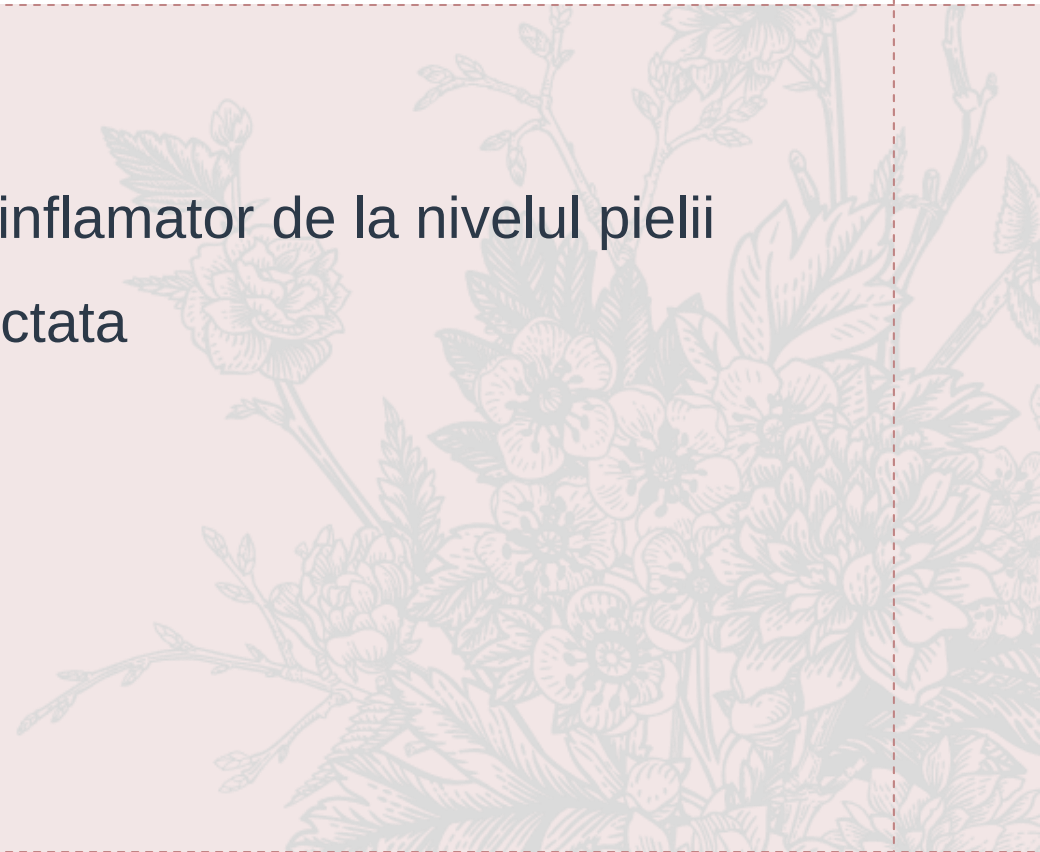
Dermatite

= Eczeme

= un grup de afectiuni care demonstreaza un raspuns inflamator de la nivelul pielii

- Sunt caracterizate de eritem si inflamatie in zona afectata

Pruritul este prezent!



Dermatite

- ♦ **ACUTE**



Eritem+ vezicule

- ♦ **SUBACUTE**



Eritem+ cruste, scuame

- ♦ **CRONICE**



Eritem+ scuame,
lichenificatie

Dermatita de contact

Este cauzata de factori externi;

Se deosebesc: dermatita iritativa si dermatita alergica de contact

Dermatita iritativa de contact

Este cea mai frecventa

La locul de contact cu substanta cauzatoare



Dermatita iritativa de contact

Apare la **majoritatea** persoanelor expuse

Severitatea inflamatiei este data de concentratia substantei si durata expunerii la substanta cauzatoare

Cele mai frecvente cauze: ape contaminate, sapunuri/ detergenti, fibre sticla, particule aerogene, produse alimentare, solventi, uleiuri, etc

Faza initiala, **acuta**: eritem, **vezicule**, uneori eroziuni/ ulceratii;
senzatie de arsura, durere sau chiar prurit;

Ulterior, **cronic**: **scuame**, fisuri, cruste

Dermatita iritativa de contact a mainilor





Barbat de 50 ani, cu prurit,
senzatie de arsura,

Eruptie cutanata: eritem,
vezicule pe gat si torace
de 2 zile



APP: interventie
chirurgicala: bypass de
artera coronara

Dezinfectie de la gat la
talpi cu solutie iodata 5%

Dermatita alergica de contact



Este cauzata de factori externi, de substante pe care sistemul imun le recunoaste ca fiind straine si la care reactioneaza

Initial: vezicule, eritem → **ulterior:** scuame, lichenificare

Apare si la distanta de substanta cauzatoare

Agenti cauzatori frecventi: iedera otravitoare/ stejar salbatic, metale (nichel, cobalt), mix de parfumuri, neomicina, balsam de Peru, formaldehida, lanolina, etc

Dermatita alergica de contact



Agenti cauzatori frecventi: iedera otravitoare/ stejar salbatic, metale (nichel, cobalt), mix de parfumuri, neomicina, balsam de Peru, formaldehida, lanolina, etc

Dermatita alergica de contact



Nu apare la toate persoanele, doar la cei **predispusi**;

Proces imunologic complex- hipersensibilitate de tip 4

Dureaza de obicei 2-3 zile de la contactul cu alergenul pana la aparitia manifestarilor cutanate;



Femeie caucaziana,
insarcinata de 33 ani

Prurit intens la nivelul
scalpului, edem al fetei si
gatului

Acuzele au aparut la 3 zile
dupa ce s-a vopsit pe par
? PPD
(parafenilendiamina)

Evolutie favorabila cu
antihistaminice si steroizi

Tratament

Individualizat

Scopul este controlam acuzele

Fiecare terapie are riscuri si beneficii

Evitarea agentului cauzator

Curatare blanda, emoliente

Corticosteroizii topici, corticosteroizii sistemici, fototerapia



Principii de ingrijire ale pielii (dermatite)

Sapunuri blande, geluri de curatare syndet

Emoliente imediat dupa baie; se prefera dermatocosmetice, crème fara parfum

Cremele emoliente nu se pun imediat dupa substante tratament

Reaplicarea emolientelor ori de cate ori este necesar

Se evita produse cu parfum, coloranti, iritanti/ alergeni cunoscuti pe cat posibil

Pentru haine: ciclu de extra- clatire, detergent lichid

Haine mai largute, non-ocluzive, din bumbac (matase, etc)

Temperatura si umiditate constante, placute

Apa din piscine usuca pielea → spalare & emoliere in mod special

Dermatita atopica



Cea mai frecventa, comuna, dermatita inflamatorie recurenta a copiilor

Istoric familial pozitiv

Asociere cu: istoric personal de astm, rinita alergica si/sau eczema

Prevalenta: globala: 2.6%; in tarile industrializate: 20% copii, aprox 3% adulti;

90% debuteaza sub 5 ani, 75% remit pana in adolescenta

Prevalenta: diferita in functie de zona geografica,

Etiologie: incomplet cunoscuta

Dermatita atopica

Factori precipitanti:

- stres emotional, iritanti locali: lana, materiale sintetice, transpiratie, cosmetice, substante chimice sau alte preparate topice
- modificari climaterice sau de temperatura ambientala (caldura mare cu umiditate crescuta, frig si umiditate scazuta)
- alergeni dovediti clinic: alergeni de mediu (exp: praf de casa- acarieni, polenuri, etc) sau alergeni alimentari (exp: lapte)

Dermatita atopica

Patogeneza:

1. Anormalitati ale barierei cutanate
 2. Activare a celulelor T
 3. Raport modificat Th1/Th2 (citokine)
 4. Productie crescuta de IgE
 5. Procese imune declansate de Stafilococul aureu si toxinele produse de acesta
- 

Tablou clinic

1. Prurit
2. Eritem, scuame, fisuri, localizate pe:
 1. Fata, suprafete extensorii la copii
 2. Zone flexorii la adulti; lichenificare
3. Dermatita cronica, recurenta
4. ! Complicatii posibile: suprainfectia (bacteriana, fungica, virala)



Tratament



Controlul bolii, diminuarea simptomelor (nu vindecare completa)

1. Ameliorarea xerozei: Bai la temperatura potrivita
Geluri de curatare blande/ syndet
Utilizare de crème emoliente 1-2 apl/zi (pe intreg tegumentul)
2. Scaderea inflamatiei: tratament topic prin aplicare de corticosteroizi de potenta usoara/ medie, inhibitori de calcineurina (pe zonele afectate)
tratament sistemic cu corticoterapie, UV-NB
3. Calmarea pruritului: antihistaminice (exp Cetirizina)
4. Atentie la produsele care irita tegumentul

Dermatita seboreica

Dermatita cronica, frecventa, ce afecteaza predominant zonele seboreice

Apare la toate varstele: bebelusi, adolescenti, adulti

Clinic: eritem-scuame in zonele seboreice: scalp, sant nazo-genian, glabelar



Dermatita seboreica- Tratament

Bebelusi:ampoane baby (spuma se lasa cateva min pe scalpul umezit; prin spalare, se indeparteaza crustele); pentru cruste rezistente: uleiuri aplicate inainte de spalare

Adulti: produse pe baza de antimicotic,
sub forma deampoane: sulfura de seleniu, climbazol (exp Triple Active®),
ketokonazol (exp Nizoral sampon)
sub forma de crème: clotrimazol, bifonazol, etc



Reactii de hipersensibilitate

	Mediatori	Aparitie	Aspect clinic
Hipersensibilitate tip I	IgE, histamina, etc	15-30 minute	Urticarie, angioedem
Hipersensibilitate tip II (citotoxic)	IgM, IgG, complement	ore	necroza
Hipersensibilitate tip III (Complexe imune)	Complexe imune, IgM, IgG	ore	necroza
Hipersensibilitate tip IV (intarziat)	Celule T antigen specifice, IFN, etc	2-3 zile	eczema

Schema simplificata

Urticaria acuta



Urticaria acuta se caracterizeaza prin aparitia de placi eritemato-edematoase, bine delimitate, pruriginoase, diseminate.

Angioedemul se caracterizeaza prin edem al tesutului celular subcutanat, al mucoasei, al submucoasei din tractul respirator si gastrointestinal.

Urticaria acuta

Placi eritemato-edematoase, pruriginoase,
diseminate

<24 ore

Forma si dimensiune variate



Angioedemul

Edem palpebral, edem al buzelor, +/-edem
laringian



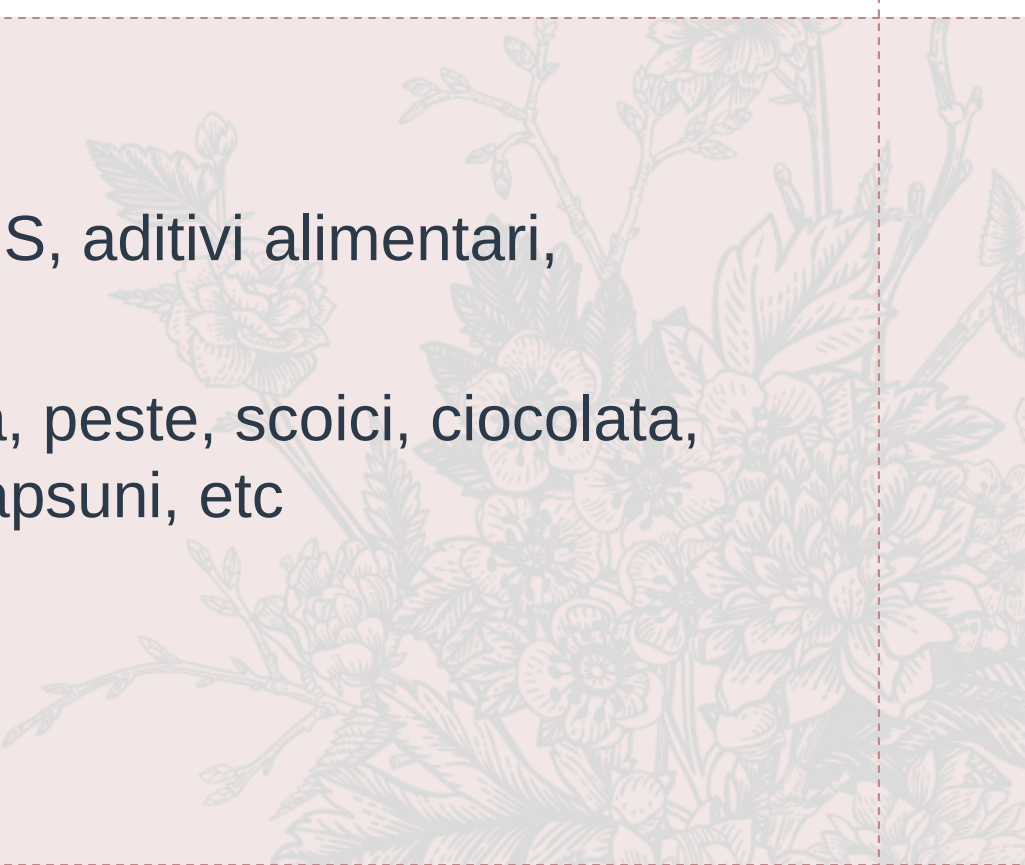
Urticaria acuta- etiologie

Cauze	Exemple
ALIMENTARE	Peste, fructe de mare, nuci, alune, capsuni, lapte, mucegaiuri
ADITIVI ALIMENTARI	Salicilati, benzoati, peniciline, sulfiti
Medicamente	Peniciline, Aspirine, sulfonamide,
Infectii	Infectii bacteriene cronice (infectii urinare sau in sfera dentara), infectii virale (virusi hepatici), paraziti intestinali
Aeroalergeni	Polenuri, mucegai, peri de animal, praf de casa (Dermatophagoides)
Boli sistemice	Neoplazii, vasculite, boli autoimune
Altele	Cosmetice, parfumuri, plante, etc

Tratament

1. Antihistaminice generatia a 2a (nonsedative): exp Desloratadina, Loratadina, Rupatadina, etc
2. Corticosteroizi sistemici:
 oral: Prednison/ Metilprednisolon;
 injectabil: HHC (hemisuccinat de hidroclonazolon);
3. Angioedem important/ anafilaxie: Epinefrina (adrenalina) sc, im

Tratament non-farmacologic

1. Identificarea si eliminarea cauzei.
 2. Evitarea factorilor triggeri comuni: aspirina, AINS, aditivi alimentari, caldura, alcool
 3. Evitarea unor alimente, precum: rosii, nuci, oua, peste, scoici, ciocolata, branzeturi fermentate, sucuri, fast food, kiwi, capsuni, etc
 4. Comprese reci, mentol, etc
- 

Vasculite

Vasculite

Un grup de patologii caracterizate prin inflamatie la nivelul peretelui vascular

Pot fi afectate vase mari, vase medii si vase mici

Vasculita leucocitoclazica- prototipul vasculitei de vase mici

Clinic: **purpura**= eritem care nu dispare la digitopresiune



Cauze

- ♦ Idiopatic
- ♦ Infectii: infectii bacteriene, virale (virus B, C)
- ♦ Neoplazii
- ♦ Boli sistemice (lupus, artrita reumatoida, etc)
- ♦ Medicamente: Aspirina, antibiotice
- ♦ (Peniciline, imunizari, contraceptive orale)

Apare o reactie imunologica de tip
antigen- anticorp (hipersensibilitate tip III)



Tratament

- ♦ Indepartarea agentului cauzator
- ♦ Repaos, pozitie decliva
- ♦ Terapie simptomatica;
- ♦ Corticoterapie locala si/sau sistemica (0.5-1mg/kgc)
- ♦ Alte imunosupresoare (metotrexat, azatioprina, imunoglobuline, etc)



Reactiile postmedicamentoase

Reactiile postmedicamentoase

Se caracterizeaza prin leziuni la nivelul tegumentului si/sau mucoaselor, ca urmare a unui medicament

Aprox. 1% din pacienti

Aprox 2% din cei cu reactii postmedicamentoase au risc de deces



Reactii postmedicamentoase

Eruptii exantematose

Cea mai frecventa manifestare a reactiilor cutanate postmedicamentoase;

Debut: trunchi, cu extindere periferica, simetrica;

Intens pruriginos

Indusa de: peniciline, sulfonamide, antiepileptice



Reactii postmedicamentoase severe

Sdr Stevens Johnson/ Necroliza epidermica toxica

Clinic: eritem, decolare a epidermului, leziuni buloase extinse, leziuni mucoase extinse

Amenintator de viata



Terapii

Terapia depinde de tipul de reactie postmedicamentoasa si de severitatea acesteia

1. Oprirea agentului incriminat
2. Comprese reci- ameliorare locala
3. Crèmele pe baza de corticosteroizi amelioreaza eruptia si pruritul
4. Preparatele sistemice pe baza de corticosteroizi sunt utile in eruptii extinse, timp de aproximativ 7-10 zile

Urticarie sau eczema?



Urticarie sau dermatita atopica?

